

PROTOTIP D'UNA GUIA PSICOEDUCATIVA PER A FAMILIARS DE PERSONES AMB CÀNCER AL LLARG DEL PROCÉS ONCOLÒGIC



Maria Rogés López

Facultat de Psicologia, Universitat Autònoma de Barcelona

21081: Psicologia

Dr. Antoni Font Guiteras

Treball de Final de Grau

7 de Maig del 2026

Prototip d'un Guia Psicoeducativa per a Familiars de Persones amb Càncer al Llarg del Procés Oncològic

Resum

Aquest treball presenta el desenvolupament d'un prototip d'una guia psicoeducativa destinada a familiars de persones amb càncer, tenint en compte les diverses fases del procés oncològic. L'objectiu principal és proporcionar un recurs pràctic que atengui les necessitats emocionals, informatives i de suport que viuen els familiars durant el transcurs de la malaltia. Per a la seva creació, s'ha dut a terme una revisió de la literatura científica i s'han analitzat les dades obtingudes a través d'una enquesta dirigida a familiars de persones amb la malaltia. Els resultats mostren una gran demanda d'informació sobre la malaltia, estratègies d'acompanyament i eines per a la regulació emocional. A partir d'aquests resultats, s'ha dissenyat una estructura de guia adaptada a les diferents fases del procés oncològic, incorporant un mòdul amb continguts psicoeducatius i estratègies pràctiques per al maneig emocional. Aquest prototip busca ser una eina útil per millorar el benestar dels familiars i facilitar el seu paper com a cuidadors.

Paraules clau: Càncer, familiars, cuidadors, psicoeducació, psicooncologia, regulació emocional, suport psicològic, procés oncològic, intervenció psicològica

Abstract

This study presents the development of a prototype psychoeducational guide aimed at family members of people with cancer, taking into account the different stages of the oncological process. The main objective is to provide a practical resource that addresses the emotional, informational, and support needs experienced by relatives throughout the course of the illness.

For its development, a review of the scientific literature was conducted, and data obtained through surveys administered to family members of people with the disease were analyzed. The results show a strong demand for information about the disease, guidance strategies, and tools for emotional regulation. Based on these findings, a guide structure was designed and adapted to the different phases of the oncological process, incorporating psychoeducational content and practical strategies for emotional management. This prototype aims to be a useful tool to improve the well-being of family members and facilitate their role as caregivers.

Keywords: Cancer, family members, caregivers, psychoeducation, psycho-oncology, emotional regulation, psychological support, oncological process, psychological intervention

Introducció

En els darrers anys, l'atenció als pacients amb càncer ha experimentat un canvi, desplaçant-se progressivament de l'entorn hospitalari cap al domicili. Això és a causa de l'augment dels serveis ambulatoris per al seu tractament, la disminució de visites hospitalàries, més taxa de supervivència i la voluntat dels cuidadors d'adaptar-se al desig dels pacients de rebre atenció a casa (Glajchen, 2004). En aquest context, el cuidador familiar ha pres un paper fonamental, convertint-se en el principal suport del pacient (Coyne et al., 2020). De fet, s'estima que els cuidadors familiars proporcionen entre el 70% i el 80% de l'atenció total que reben les persones amb càncer (Given et al., 2012).

Ara bé, aquest canvi en el model d'atenció, que trasllada la responsabilitat principal cap als familiars, té importants repercussions emocionals i socials per a ells (Coyne et al., 2020). La necessitat d'adaptar-se a les exigències de la malaltia i als efectes dels tractaments sovint obliga els cuidadors a canviar els seus hàbits i patrons de socialització, cosa que pot portar-los a situacions d'aïllament i dolor emocional (Puerto Pedraza, 2015). Aquest malestar pot manifestar-se com a estrès, irritabilitat, apatia o tristesa i, si es manté durant un període prolongat, pot derivar en trastorns psicològics i problemes físics, com ara pèrdua de pes, cefalees, ansietat o depressió (Coyne et al., 2020; Northouse et al., 2012).

La literatura mostra que les demandes emocionals dels cuidadors poden canviar segons l'etapa de la malaltia. Northouse et al. (2012) descriuen diverses fonts d'angoixa al llarg del procés oncològic, des del diagnòstic fins a les fases del tractament o de malaltia avançada. A més, els cuidadors no només s'enfronten a l'impacte emocional de la situació, sinó que també

assumeixen una gran varietat de tasques complexes, com el maneig de símptomes, la presa de decisions i donar suport emocional al pacient, funcions que requereixen unes habilitats cognitives i emocionals demandants (Given et al., 2012). Però, tot i aquesta alta exigència, estudis revelen que els cuidadors tenen un gran nombre de necessitats insatisfetes: Stenberg et al. (2010) en van identificar més de 200, destacant especialment la falta d'informació, dificultats relacionades amb l'experiència de les cures i problemes de comunicació. Això posa de manifest que, sovint, els cuidadors donen suport al pacient amb les seves pròpies necessitats insatisfetes. I, tot i que s'ha demostrat que les intervencions dirigides als familiars poden disminuir el seu malestar emocional, aquestes continuen sent poc explorades en la pràctica i les seves necessitats sovint no són reconegudes (Coyne et al., 2020; Northouse et al., 2012).

En revisar els recursos disponibles, s'observa com algunes organitzacions internacionals, com l'American Cancer Society (2025), ofereixen guies completes i fàcilment accessibles per als cuidadors. Ara bé, a escala estatal els recursos són més escassos; l'Associació Espanyola Contra el Càncer (2025), tot i que proporciona serveis de suport, es concentra principalment en la derivació a professionals i no compta amb materials psicoeducatius de consulta directa. Això fa que sigui més complicat per als cuidadors poder trobar recursos i informació de fàcil accés i immediates.

Al llarg del treball, s'utilitza el terme *familiar* per referir-se a les persones que exerceixen un rol de cura i acompanyament. Cal destacar que aquest terme s'utilitza en un sentit ampli, incloent-hi no només els membres de la família, sinó també aquelles persones cuidadores que no tenen cap relació de parentiu.

Objectiu

Davant aquesta realitat, diversos autors destaquen la importància d'implementar intervencions preventives i primerenques per a poder reduir el malestar psicològic dels cuidadors i evitar l'aparició de trastorns mentals (Hodges et al., 2005; Cuijpers et al., 2021; Zhou et al., 2023; Irarrázaval et al., 2016). En aquest context, en les últimes dècades s'han creat models psicoeducatius que combinen informació i suport emocional amb l'objectiu d'enfortir el sentiment de competència i millorar el benestar dels cuidadors (Chiquelho et al., 2011). L'evidència científica demostra que aquests tipus d'intervencions ajuden a reduir l'ansietat, la depressió i la càrrega emocional, alhora que milloren els coneixements, les estratègies d'afrontament i la qualitat de vida (Donker, 2009; Northouse et al., 2012). A més, l'autoajuda guiada s'ha mostrat com una eina accessible i útil que pot utilitzar-se com a complement del suport professional (McCann & Lubman, 2014; Vissupe et al., 2016).

En resum, tot i que hi ha intervencions dissenyades per als familiars de persones amb càncer, la majoria encara se centren principalment en la cura al pacient, deixant de banda les necessitats emocionals dels cuidadors. La falta de recursos psicoeducatius destaca la necessitat de crear materials específics que ajudin a prevenir el malestar psicològic dels familiars i promoguin la seva salut. En aquest sentit, l'objectiu d'aquest Treball de Fi de Grau és explorar les necessitats, mancances i experiències dels familiars de persones amb càncer, amb la finalitat de definir i crear un prototip de com hauria de ser una guia psicoeducativa que s'ajusti a la realitat, tenint en compte les necessitats específiques de cada fase del procés oncològic. Aquesta recerca prèvia busca oferir una base fonamentada que orienti a professionals en el desenvolupament

d'una futura guia completa. Per tant, aquest projecte té la finalitat, no només de recopilació i anàlisis d'informació, sinó del desenvolupament d'un producte que pugui servir de referència per a generar guies destinades a la població interessada.

En conseqüència, la principal proposta d'aquest treball és desenvolupar un prototip complet i elaborat d'una guia psicoeducativa que s'ajusti el millor possible a les necessitats reals dels familiars, tenint en compte les tres fases principals del procés oncològic: La fase de tractament, la fase de finalització del tractament (controls posteriors a la superació de la malaltia) i la fase de malaltia avançada o final de vida. Aquest prototip s'ha construït a partir de les necessitats concretes expressades pels participants a través d'una enquesta pròpia, com també d'una revisió de la literatura i consell d'experts.

Aquesta divisió per fases es fonamenta en el fet que les necessitats emocionals i pràctiques dels familiars varien en cada etapa del procés (Yang et al., 2021). Per això, adaptar la guia per a satisfer les necessitats en les diferents etapes de la malaltia és crucial per a millorar el benestar personal (Overchuk et al., 2024). A més, estudis com els de Kim i Given (2008), suggereixen que la qualitat de vida dels cuidadors de persones amb càncer varien al llarg de la trajectòria de la malaltia, això ressalta la importància de fer un ajustament continu al llarg del procés.

Mètode

El treball ha sigut desenvolupat seguint la següent metodologia:

1. Analitzar les dades d'una enquesta realitzada per a conèixer les experiències i opinions dels familiars de persones amb càncer.
2. Definir com hauria de ser una guia psicoeducativa que s'ajusti a les seves necessitats depenent de la fase oncològica on es trobi el pacient.

La principal font de recollida de dades és una enquesta pròpia que inclou una mostra de 56 persones, amb el criteri que responguessin familiars de pacients amb càncer. D'aquesta mostra vaig haver-ne d'eliminar 9 que eren pacients mateixes de càncer (informació que considero valuosa, però no formaven part del grup diana específic per aquest treball). Finalment, em vaig quedar amb una mostra de 47 persones. La manera com es va difondre l'enquesta va ser, per una banda, a través del boca-orella, per l'altre, van contribuir a la seva difusió una psicooncòloga oncològica de l'Associació Maresme Oncològic i una infermera de l'Hospital de Mataró, el que va facilitar l'accés a persones que han viscut diferents etapes del procés. Es va procurar incloure persones amb diversos tipus de relació amb el pacient i en diferents moments de la malaltia, amb la intenció de recollir diverses experiències.

L'enquesta va ser dissenyada específicament per a aquest projecte utilitzant Google Forms. Inclou tant preguntes tancades, per poder quantificar les respostes, com preguntes obertes, per aprofundir en l'experiència personal dels participants. La seva creació es va realitzar de la següent manera:

- Amb el suport d'una psicooncòloga de l'Associació Maresme Oncològic, qui va proporcionar orientació sobre les diferents fases de la malaltia i els temes que solen ser més recurrents en teràpia.
- Una revisió de la literatura per identificar necessitats i mancances més comunes per complementar-ho. Extrets, majoritàriament, dels estudis realitzats per Northouse et al. (2012) i els de Stenberg et al. (2010).

L'enquesta va ser difosa en línia i, quant a les **consideracions ètiques**, les dades van ser recollides de manera anònima i voluntària, amb una breu explicació sobre l'objectiu del treball per assegurar que la participació sigui informada. A més, els continguts de l'enquesta com del treball han respectat la dignitat tant dels familiars com dels pacients, tenint en compte la necessitat de cuidar el benestar emocional dels cuidadors en qualsevol moment. Finalment, tota la informació presentada ha sigut neutra i sense biaixos, utilitzant un llenguatge inclusiu i sensible a les diverses realitats, com també s'ha tingut en compte al moment de redactar aquest informe.

Per construir l'estructura, s'han analitzat les respostes dels participants, agrupant-les segons aquestes tres fases. L'objectiu ha estat identificar si hi havia diferències en les necessitats esmentades, quins temes es consideraven més prioritaris en cada etapa i quins aspectes generaven més angoixa. L'anàlisi s'ha centrat especialment en les preguntes obertes de l'enquesta. Finalment, aquestes respostes s'han revisat i classificat en categories temàtiques per identificar els àmbits de necessitat.

L'anàlisi qualitativa de les preguntes obertes es va dur a terme mitjançant un procés de codificació inductiu. Inicialment, vaig llegir totes les respostes per obtenir una visió general del contingut, per a seguidament crear un esbós de categories basat en els temes que es repetien. Vaig fer una segona revisió del contingut, on a cada resposta es va assignar a la categoria que millor reflectia el seu significat. La classificació es va fonamentar en el contingut semàntic de les respostes, diferenciant, per exemple, entre sol·licituds d'informació sobre el procés oncològic, o manifestacions d'incertesa i por davant l'evolució de la malaltia, entre d'altres. Aquest procés va facilitar l'agrupament de les experiències dels participants en diversos àmbits que, tot i ser diferents, eren coherents amb el que havien expressat.

Alhora, s'ha tingut en compte la pregunta final; *Quins temes consideres més útils per incloure en una guia per a familiars?* que, al ser concreta, ha ajudat a prioritzar els temes més rellevants. Després, s'han revisat de nou les respostes obertes originals (abans de ser agrupades en categories) per recuperar les demandes específiques dels participants. Aquesta revisió més detallada ha servit per definir els subapartats dins de cada bloc temàtic, assegurant que la proposta final reflecteixi les preocupacions i experiències reals.

Resultats amb Evidència

Anàlisi dels Resultats de l'Enquesta

Les dades de l'enquesta s'han analitzat de la següent manera:

- Per les **dades quantitatives** s'han utilitzat percentatges, amb l'objectiu d'identificar quins eren els patrons més destacats.

- Per a les **dades qualitatives** s'ha fet una agrupació temàtica per a poder detectar categories recurrents i les necessitats específiques dels participants.

Aquesta anàlisi es troba detallada a l'apartat d'Annexos.

En la valoració de les tres fases del procés oncològic s'han pogut identificar patrons consistents que es mantenen al llarg del temps, independentment de l'etapa de la malaltia. En totes elles es destaca:

Falta d'Orientació Emocional. En la fase de tractament, un 62,5% dels participants indiquen que no va rebre cap mena d'acompanyament emocional quan es va fer el diagnòstic. Aquest percentatge es manté força similar en la fase de finalització del tractament, amb un 60,9%, i augmenta en la fase de malaltia avançada, amb un 66,7%. Aproximadament sis de cada deu familiars no van rebre suport emocional en el moment inicial del procés.

Necessitat d'Ajuda Professional. En la fase de tractament, un 75% dels participants reconeix haver sentit la necessitat de rebre suport professional, en la fase de finalització del tractament, aquesta necessitat es redueix al 52,2%, però en la fase de malaltia avançada, torna a augmentar fins al 66,7%. En totes les etapes més de la meitat dels participants expressen la necessitat d'acompanyament psicològic, el que indica que el malestar emocional es manté al llarg de tot el procés.

La Por i la Incertesa. Durant la fase de tractament, un 50% dels participants assenyalen que el tema més difícil d'afrontar és la por i la incertesa sobre l'evolució de la malaltia, i en la fase de finalització del tractament la incertesa continua sent un tema central, tot i que disminueix al 24%. A més, també s'ha de tenir en compte que la categoria *Com afrontar la por, la tristesa o la incertesa* és considerat important pel 87,5% en tractament, pel 73,9% en la fase de finalització i pel 100% dels participants en fase de malaltia avançada. La por i la incertesa apareixen com una de les principals dificultats emocionals dels familiars al llarg de totes les etapes.

Utilitat d'una Guia Psicoeducativa. En les tres fases analitzades, tots els participants (100%) coincideixen que una guia psicoeducativa per a familiars seria molt útil. Aquesta uniformitat destaca la necessitat d'una guia psicoeducativa per a familiars, com la necessitat de rebre recursos informatius i de suport emocional durant tot el procés.

Comunicació i Suport Emocional. El tema *Com comunicar-se amb la persona afectada* és destacat dins l'enquesta pel 87,5% dels participants durant la fase de tractament, pel 73,9% en la fase de finalització i pel 80% en la fase de malaltia avançada. De manera similar, *Com donar suport a la persona afectada* és seleccionat pel 87,5% en tractament, pel 65,2% en la finalització del tractament, i pel 66,7% en malaltia avançada. En totes les fases, entre el 65% i el 100% dels participants donen prioritat a continguts relacionats amb la comunicació, el suport emocional i la gestió de les emocions, el que ressalta una alta necessitat de recursos que abastin aquests aspectes.

Necessitat d'Informació sobre la Malaltia i el seu Procés. Aquesta necessitat es manté present durant les tres fases del procés oncològic, però amb diferents nivells d'intensitat. Durant la fase de tractament, un 62,5% dels participants creuen que hauria estat molt útil tenir informació sobre la malaltia i el seu procés des del principi. En la fase de finalització del tractament, aquest percentatge baixa al 35%, i en la fase de malaltia avançada, es redueix al 25%. Malgrat aquesta disminució, la necessitat d'informació clara i comprensible és una necessitat manifestada durant tot el procés, especialment en les fases inicials.

Efectes del Tractament i Deteriorament Físic. Tot i que els percentatges no són tan alts en comparació amb altres temes, és un aspecte que es repeteix en les tres fases (25% en tractament, 20% en finalització i 11,8% en malaltia avançada). Aquesta recurrència mostra que és una preocupació present durant el procés oncològic. Per aquest motiu s'ha considerat important que el prototip inclogui un apartat específic per entendre els efectes del tractament i els canvis físics associats.

Anàlisi de la Literatura

Northouse et al. (2012), esmenta les principals fonts de preocupació per als familiars en les diferents fases del procés oncològic. Entre elles es destaca:

Fase de Tractament. Preocupacions per l'eficàcia del tractament, dificultats per gestionar els efectes secundaris del tractament, manca de preparació per proporcionar suport, dificultat per compaginar múltiples demandes sense suport d'altres persones, i l'aïllament social.

Fase de Finalització del Tractament. Por a la recurrència de la malaltia, presència d'estressors afegits a l'historial de càncer, augment de la incertesa i la desesperança, inestabilitat emocional, menys fonts de suport.

Fase de Malaltia Avançada. Alt nivell de malestar, relacions familiars conflictives, sentiments d'abandonament, manca de suport, autocura deficient.

A més, es tenen en compte les necessitats destacades com insatisfetes dels estudis de Stenberg et al. (2010). Entre aquestes es destaquen; la necessitat d'informació durant tot el procés, problemes de comunicació, i dificultats per acompanyar en les cures del pacient.

Continguts del Producte

A partir de l'anàlisi de les dades obtingudes mitjançant l'enquesta, s'ha pogut identificar una sèrie de necessitats que es repeteixen entre els familiars de persones amb càncer, que apareixen de manera constant durant les diferents fases del procés oncològic. Entre aquestes necessitats, es destaca la falta d'orientació emocional, la demanda de suport psicològic, la presència de por i incertesa, les dificultats en la comunicació amb la persona afectada, i la necessitat d'informació sobre la malaltia i el seu procés. Aquests temes, que s'han identificat com els més importants, han estat prioritzats en el disseny del prototip de la guia, per tal d'assegurar que el contingut s'ajusti a les necessitats reals dels familiars. En aquest sentit, la guia s'estructura en diversos blocs:

Introducció. En aquest apartat, es presenta la guia, es defineix què és la psicooncologia, s'identifica a qui es dirigeix i per què és tan important aquest recurs en l'àmbit oncològic. La

seva funció és situar el producte en el seu context, facilitant la comprensió de l'escenari en què sorgeix la guia i la seva utilitat dins del procés oncològic. Alhora, pretén ajudar a entendre millor per a què serveix el recurs i quin tipus de necessitats pretén cobrir, així com fomentar l'interès i la implicació activa dels familiars en el seu ús des del primer moment.

Comprendre el Procés Oncològic. S'inclou una explicació de les diferents etapes del procés oncològic (tractament, finalització del tractament i fase avançada), així com els possibles efectes físics, emocionals i els canvis en la vida quotidiana. L'objectiu és proporcionar informació clara i accessible sobre el procés oncològic, amb la finalitat de facilitar una millor comprensió de la situació que viu el cuidador. Aquesta informació s'adapta a les diferents fases del procés per tal d'ajudar a el familiar a entendre què pot esperar en cada etapa i acompanyar-lo perquè pugui comprendre millor el que està passant el pacient.

Impacte Emocional al Llarg del Procés. Pretén proporcionar suport als familiars davant del desgast psicològic que comporta acompanyar una persona amb càncer. Ajuda a identificar i comprendre emocions freqüents, normalitzant aquestes reaccions com a part de la situació viscuda. A més, aborda necessitats emocionals pròpies de cada etapa del procés oncològic, com també inclou estratègies pràctiques de regulació emocional. El seu objectiu és ajudar els familiars a entendre i validar les seves emocions durant el procés, promovent més consciència emocional davant les dificultats que afronten. Al mateix temps, busca prevenir la sobrecàrrega emocional que pot sorgir del rol de cuidador i fomentar estratègies d'afrontament més adaptatives, que ajudin a reduir el malestar psicològic i a mantenir el seu benestar personal.

Acompanyament a la Persona Afectada. Es proporcionen orientacions per a l'acompanyament emocional de la persona afectada, així com eines de comunicació que poden facilitar la relació durant tot el procés oncològic, com ara l'escolta activa, l'empatia i l'assertivitat. L'objectiu és millorar la qualitat de la relació entre el familiar i el pacient, afavorint una comunicació més efectiva i adaptada a les necessitats de cada moment. A més, es pretén dotar els familiars de recursos pràctics que els permetin acompanyar de manera més adequada i segura al llarg de les diferents etapes del procés oncològic.

Suport Social i Familiar. En aquest apartat es destaca la importància de la xarxa de suport, s'ofereixen estratègies per demanar ajuda i es promou la compartició tant de responsabilitats com d'emocions dins l'entorn familiar i social. La seva funció és reduir la sensació d'aïllament que sovint poden experimentar els cuidadors, fomentar el suport mutu entre les persones de l'entorn proper i disminuir la càrrega física i emocional percebuda pels familiars cuidadors, afavorint així un afrontament més equilibrat de la situació.

Recursos de Suport. Recull informació sobre els diferents serveis disponibles a l'abast dels familiars, com ara l'atenció psicològica, les associacions de pacients, els grups de suport i altres recursos comunitaris. L'objectiu és facilitar l'accés a ajuda especialitzada quan sigui necessari, fomentar la cerca de suport extern més enllà de l'entorn familiar, i ampliar el ventall de recursos disponibles per afrontar la situació de manera més acompanyada i efectiva.

Desenvolupament del Mòdul: *Gestionar les Pròpies Emocions i l'Estrès*

A part del prototip de la guia psicoeducativa, també es presenta una proposta d'un dels mòduls desenvolupats. En concret, el mòdul *Gestionar les pròpies emocions i l'estrès*, atesa la seva rellevància en el benestar emocional de les persones cuidadores durant el procés oncològic.

El mòdul s'estructura en dues parts: Per començar, hi ha un bloc teòric-educatiu que ajuda a entendre les emocions, fomentant la seva normalització i reconeixement. Es tracten temes com l'impacte emocional que comporta ser cuidador, les emocions més comunes en aquesta situació i la seva funció adaptativa, així com la importància de saber regular-les per millorar el benestar. Seguidament, es presenten i justifiquen diverses estratègies de regulació emocional que s'inclouen en el mòdul, juntament amb els seus beneficis.

A Annexos es troba el mòdul com apareixeria integrat dins la guia.

Entendre les nostres emocions.

Cuidar a algú amb càncer implica impacte emocional. La càrrega que comporta la malaltia i els tractaments fa que els cuidadors sovint hagin de canviar els seus hàbits i maneres de socialitzar, el que pot portar a situacions d'aïllament i patiment. Com a resultat, poden aparèixer problemes físics i emocionals, que es manifesten en estrès, irritabilitat, apatia o tristesa (Puerto Pedraza, 2015). Si aquest estrès es manté durant un període prolongat, pot conduir a trastorns psicològics i afectar el sistema immunitari, amb símptomes com pèrdua de pes, falta de gana, mals de cap, ansietat o depressió (Coyne et al., 2020; Northouse et al., 2012). Tot això pot

deteriorar progressivament la qualitat de vida del cuidador, on sovint aquests efectes són poc reconeguts o no s'aborden adequadament pels professionals de la salut (Puerto Pedraza, 2015).

La literatura indica que els cuidadors familiars de persones amb càncer pateixen tant malestar físic com emocional, a més d'una falta de coneixement i suport per fer front a les exigències de la cura. Aquest malestar pot estar vinculat a les tasques d'atenció directa, a procediments mèdics complicats, a la interrupció de les rutines diàries, a la sobrecàrrega de rols o a la necessitat de proporcionar suport emocional constant, i sovint es manté al llarg del temps (McCorkle & Given, 2012).

Quines emocions apareixen? Els cuidadors de persones amb càncer viuen una gran varietat d'emocions, amb un clar predomini de les negatives sobre les positives. Entre les més comunes, hi trobem la tristesa, la por i el fàstic, així com altres sentiments com el remordiment, la desesperació o la vergonya (Filipponi et al., 2024). Aquesta gamma emocional inclou tant emocions individuals, com la por o la desesperació, com també emocions socials, com la vergonya o el bloqueig emocional. Malgrat que les emocions negatives són les més presents, també hi ha espai per a les positives, com la confiança o l'esperança, que poden servir com a factors protectors en moments clau del procés (Filipponi et al., 2024).

A més, la intensitat i el tipus d'emocions poden canviar segons el moment de la malaltia. Durant els primers 9 mesos del tractament s'ha observat un augment notable del malestar emocional, especialment en forma d'estrès, ansietat i depressió, que es relaciona amb necessitats no satisfetes en la cura personal del cuidador. En etapes més avançades (més de 9 mesos),

aquestes necessitats no ateses continuen tenint un impacte significatiu, especialment en l'augment de l'estrès i l'ansietat (Yang et al., 2021). Aquestes dades indiquen que els familiars es troben en situació de vulnerabilitat emocional al llarg de tot el procés, on la sobrecàrrega i la falta d'atenció a les mateixes necessitats poden intensificar el malestar. Aquest malestar emocional es manifesta com una preocupació constant, amb dificultats per gestionar les demandes de la cura i aïllament social (Northouse et al., 2012).

Aquests resultats són coherents amb les dades obtingudes en l'enquesta pròpia, on els participants mencionen emocions com la por, la incertesa, la tristesa, la impotència, l'angoixa, o la soledat, entre d'altres. És important destacar que una part significativa dels cuidadors (61,7% dels enquestats) ha expressat la necessitat d'ajuda professional, el que evidencia la presència d'un malestar emocional considerable.

Les emocions són adaptatives. Des d'una perspectiva evolutiva, les emocions juguen un paper adaptatiu molt important, ja que preparen el nostre cos per afrontar situacions que són clau per a la supervivència. Cada emoció desencadena respostes fisiològiques i conductuals específiques que, al llarg de la història de l'espècie, han demostrat ser útils per gestionar situacions que es repeteixen (Janocha et al., 2018).

Les emocions negatives, com la por o la ràbia, poden provocar canvis fisiològics que ajuden el cos a fer front a amenaces. Per exemple, la ràbia activa el sistema nerviós simpàtic, augmentant la freqüència cardíaca i la pressió arterial, i preparant-nos per defensar-nos. D'altra banda, la por pot provocar una resposta de paralització temporal que ens permet avaluar la

situació i actuar amb precaució. Encara que aquestes reaccions poden semblar desadaptatives, en realitat compleixen funcions essencials de protecció i regulació davant del perill (Janocha et al., 2018).

De manera similar, la tristesa pot reduir la nostra energia i fomentar processos d'introspecció, ajudant-nos a gestionar pèrdues i a adaptar-nos a noves circumstàncies. Tant les emocions negatives com les positives són fonamentals per construir recursos personals i regular les nostres interaccions socials, essent essencials per al nostre desenvolupament i equilibri emocional (Janocha et al., 2018).

Malgrat aquest aspecte adaptatiu, les emocions poden convertir-se en perjudicials si es mantenen fora d'un rang funcional. En aquest sentit, juguen un paper regulador en la salut: quan les experimentem i gestionem adequadament, afavoreixen al nostre benestar general; però si són excessives, persistents o mal regulades, poden contribuir a desregulacions i malalties (Mayne, 2001).

La importància de regular les nostres emocions. La regulació emocional és el procés que permet a les persones gestionar les seves emocions i ajustar el comportament per adaptar-se a les circumstàncies, aconseguir metes i promoure el seu benestar, tant en l'àmbit personal com social. No es tracta d'eliminar les emocions, sinó d'aprendre a manejar-les de manera flexible i adaptativa, segons el que requereix cada situació (Pérez & Bello, 2017).

Aquesta regulació es pot realitzar mitjançant diverses estratègies cognitives i conductuals, que poden ser automàtiques o intencionals, i que busquen modificar tant la intensitat com la durada de les emocions que experimentem. L'objectiu és facilitar l'adaptació a l'entorn, optimitzar els recursos personals i mantenir un equilibri entre les necessitats individuals i les exigències externes (Pérez & Bello, 2017).

Quan la regulació emocional es fa de manera adequada, té un impacte positiu en la salut física i psicològica, contribuint al benestar general i reduint el risc de patir problemes de salut mental i física. D'altra banda, les estratègies de supressió o inhibició emocional s'han relacionat amb conseqüències negatives, com alteracions respiratòries, gastrointestinals o cardiovasculars, així com un empitjorament del benestar psicològic (Pandey & Choubey, 2010).

Per tant, aprendre a regular les emocions no només ajuda a gestionar millor les situacions de cura, sinó que també es converteix en una eina essencial per preservar la salut i sostenir el rol de cuidador de manera més saludable i sostenible.

Estratègies de regulació emocional.

La respiració profunda. Dins del món de les tècniques psicofisiològiques, hi trobem les tècniques bioenergètiques, que es fonamenten en la respiració. L'objectiu d'aquestes tècniques és activar la funció fisiològica per tal d'augmentar el nivell energètic de l'organisme i millorar la capacitat de controlar conscientment els seus estats. Això facilita la regulació de la mobilització de les energies biològiques segons els objectius de l'activitat (Rodríguez et al., 2005).

Entre els principals beneficis, podem destacar (Rodríguez et al., 2005):

- Actua com un antídoto contra l'estrès.
- Afavoreix una correcta oxigenació de la sang, el que ajuda a millorar l'ansietat, la depressió, la fatiga i la irritabilitat.
- Contribueix a reduir la tensió muscular.
- S'utilitza tant en el tractament com en la prevenció de problemes.
- Té valor preventiu davant de factors de risc associats a diverses malalties.

Segons Morales (2018), les tècniques de respiració es poden classificar, de manera general, en diferents tipus: respiració diafragmàtica, toràcica i clavicular. La combinació d'aquestes tres formes dona com a resultat la respiració completa, que és considerada la més adequada per aconseguir una regulació emocional.

La **respiració diafragmàtica** o abdominal és la manera més natural i eficient de respirar. Aquesta tècnica permet aprofitar al màxim la capacitat pulmonar amb un esforç mínim, ja que s'encarrega de ventilar la part inferior dels pulmons. A més, la implicació dels músculs abdominals ajuda a aconseguir una respiració més profunda (Marelis Ortega-Pérez et al., 2023).

Entre els seus múltiples beneficis, Marelis Ortega-Pérez et al. (2023) destaca:

- Més aportació d'oxigen als pulmons.
- Neteja i ventilació eficient dels pulmons.
- Activació de la resposta de relaxació.
- Estimulació del sistema cardiovascular.

Segons García-Grau et al. (2008), algunes de les característiques d'aquesta tècnica respiratòria són el descens lent del diafragma, que proporciona un massatge abdominal molt efectiu, l'ompliment complet d'aire de la part inferior dels pulmons i, durant l'expiració, un buidatge molt eficient dels pulmons.

La **respiració toràcica** o costal és un tipus de respiració que permet que el tòrax s'expandeixi en diverses direccions: lateral, anterior i posterior. Aquesta acció es realitza gràcies als músculs intercostals, que juguen un paper clau en la contracció i dilatació de la part mitjana dels pulmons (Bernal Ruíz, 2020).

Algunes de les seves característiques, segons Marelis Ortega-Pérez et al. (2023) són:

- L'expansió de la caixa toràcica.
- L'ús de la musculatura intercostal.
- Una millora de la capacitat pulmonar.

Es recomana combinar aquesta tècnica amb la respiració abdominal, ja que això ajuda a aconseguir un efecte relaxant (Marelis Ortega-Pérez et al., 2023).

La **respiració clavicular** és una respiració superficial que necessita un esforç considerable per aconseguir una quantitat limitada d'aire. Quan inspirem, les clavícules s'eleva i, sovint, també les espatlles. A la pràctica, ofereix pocs beneficis i sol ser la fase final de la inspiració. Per això, es recomana combinar-la amb altres tipus de respiració (Marelis Ortega-Pérez et al., 2023)

Principals característiques (Marelis Ortega-Pérez et al., 2023):

- Només ventila la part superior dels pulmons.
- Té una eficàcia limitada.
- S'associa sovint a moments d'angoixa.

La **respiració completa** és una tècnica que combina la respiració abdominal, toràcica i clavicular, i això permet que els pulmons s'omplin al màxim. Aquesta forma de respirar implica expandir el tronc en totes les direccions, però cal practicar-la per dominar-la bé (Marelis Ortega-Pérez et al., 2023).

Els seus avantatges són molts, entre ells (Marelis Ortega-Pérez et al., 2023):

- Regulació de l'ansietat, irritabilitat i nerviosisme
- Reducció de la tensió muscular i la fatiga
- Millora del control de la pressió arterial
- Foment de sensacions de calma i relaxació

Mindfulness. La pràctica de *mindfulness* pertany a la tradició *Vipassana*, que significa viure el moment present tal com és, de manera objectiva i sense reaccionar, aprenent a acceptar allò que no es pot canviar (López-Hernández, 2016). En contraposició d'aquesta atenció conscient és troba la insensatesa, estat en que les persones acostumen a viure la major part del temps, sovint immerses en les seves preocupacions, ruminacions sobre el passat i anticipacions del futur (Weare, 2012). Aquesta insensatesa afavoreix que l'experiència es visqui a través de judicis i etiquetes que condicionen el comportament, alhora que genera desconexió tant mental com corporal. En conseqüència, es redueix la consciència dels senyals d'estrès i manifestacions físiques associades a les emocions negatives (Weare, 2012).

La pràctica regular de *mindfulness* s'ha associat amb més benestar emocional i una experimentació freqüent d'emocions positives. Així mateix, pot contribuir a una millor salut física i psicològica, un augment de la resistència davant l'estrès i més satisfacció en les relacions interpersonals (William i Penman, 2010). A més, aquesta pràctica afavoreix el desenvolupament de funcions integradores que generen més connexions neuronals, entre les quals es destaquen les funcions reguladores corporals, la coherència, l'equilibri emocional, la flexibilitat de les respostes davant les diferents situacions de la vida, la pèrdua de la por, la comprensió, l'empatia i alts nivells de moralitat i intuïció (Siegel, 2012).

Alguns dels elements clau del *mindfulness*, segons Germer (2005), són:

- Prendre atenció i consciència sense centrar-se en els processos de pensament implicats.
- Centrat en el present: sempre es dona en i sobre el moment present.
- No valoratiu: no es pot experimentar plenament alguna cosa que es desitja que sigui una altra.
- Intencional: sempre hi ha una intenció de centrar-se en alguna cosa i de tornar-hi si per algun motiu s'ha desviat.
- Observació participativa: no és una observació distanciada o aliena, ha d'implicar al màxim la ment i el cos.
- No verbal: l'experiència de mindfulness és de referent emocional i sensorial, no verbal.
- Exploratori: obert a l'experimentació sensorial i perceptiva.

- Alliberador: cada moment d'experiència viscuda plenament és una experiència de llibertat.

Les tècniques busquen, sobretot, que la persona es deixi portar per les sensacions que percep. Es tracta de promoure, com a punt fonamental de referència, les sensacions i emocions, deixant que aquestes actuïn de manera natural. Això possibilita que la persona permeti que determinades activitats (emocions, canvis fisiològics, etc.) que operen de manera autònoma (SNA) es regulin d'acord amb els seus propis sistemes naturals d'autoregulació (Pareja, 2006).

La manca d'informació sensorial, ja sigui activa (ús de tècniques de control, distracció, etc.) o passiva (no atenent de manera intencional aquesta informació), impedeix a l'organisme disposar de la informació precisa i necessària perquè tinguin lloc els modes naturals d'aprenentatge. L'intent de bloquejar el malestar, les emocions o l'estrès contravé i altera, de manera física (fàrmacs) o psicològica (distracció, reestructuració, etc.), els mecanismes de retroalimentació naturals de l'organisme que permeten regular-se (Pareja, 2006).

Petites Pràctiques de Mindfulness en el Dia a Dia. Tot i que la pràctica del *mindfulness* es pot integrar en el dia a dia, sovint es presenten dificultats per a mantenir-la de manera estable i continuada. En aquest sentit, la programació d'un moment concret del dia dedicat específicament a aquesta pràctica pot resultar útil. Sovint s'atribueix la falta de temps a les obligacions laborals, socials o familiars, tanmateix, aquesta dificultat es relaciona més aviat cap a una manca de consciència. Per a això es proposa reservar espais i temps sense obligacions externes per afavorir una bona pràctica del *mindfulness* (Kessen, 2009).

Les pràctiques útils per a incorporar en la vida quotidiana proposades per Kessen (2009) són: Practicar la consciència corporal (body scan), la meditació asseguda o dret, caminar de manera conscient, practicar la tècnica del mig somriure, com practicar el mindfulness durant les activitats diàries (vegeu *Annexos*).

Esriptura emocional. Escriure sobre una experiència obliga al cervell a estructurar idees i això permet que, en moltes ocasions, s'analitzi el contingut dels pensaments i es pugui trobar un sentit als fets, així com rescatar-ne l'aprenentatge. Això és degut al fet que quan una experiència té estructura i sentit, es percep com més manejable i controlable (Lyubomirsky, 2021). Monsivais (2023) demostra que les persones que realitzen aquest procés acudeixen menys al metge, pateixen menys depressió, presenten una millor salut i milloren el seu rendiment acadèmic.

L'escriptura emocional determina que, en l'esforç per donar sentit a la vida, les persones s'enfronten amb la tasca d'organitzar la seva experiència vital en seqüències temporals, amb la finalitat d'obtenir un relat coherent d'ells mateixos i del món que els rodeja. La narració brinda a les persones un sentit de continuïtat i significat a les seves vides, fet que facilita utilitzar-les com a suport per a ordenar la quotidianitat i interpretar les experiències posteriors. Això afavoreix que la persona se separi del seu relat i el pugui observar des d'una altra perspectiva, generant així un sentiment de control en percebre's capaç d'intervenir en la seva pròpia vida (Ponciano-Rodríguez & Morales-Ruiz, 2007).

Lyubomirsky (2021) afirma que l'escriptura expressiva és una estratègia d'afrontament eficaç. Per utilitzar-la, es proposa que durant 15 a 30 minuts diaris s'escrigui sobre qualsevol experiència que produeixi malestar per explorar les emocions, els pensaments i les reaccions d'una manera més profunda. A més, Riso (2022) proposa portar un diari, ja que afirma que és una de les maneres de conèixer-se a un mateix, alhora permetent ser més conscient de les emocions, les reaccions, les accions i els pensaments. També ajuda a recordar les reaccions davant determinades situacions, així com les conductes, pensaments i emocions associades.

En la mateixa línia, Lyubomirsky (2021) manifesta que expressar gratitud és una activitat essencial per augmentar la felicitat, ja que es pot expressar de moltes maneres. A través de l'escriptura, es proposen dues activitats: escriure cartes d'agraïment personalitzades o portar un diari. El simple fet d'escriure una carta d'agraïment és suficient per produir un increment de la felicitat. D'altra banda, també s'han investigat els beneficis de portar un diari de la gratitud, on els estudis de Lyubomirsky (2021) demostren que els millors resultats d'aquesta activitat s'aconsegueixen quan es realitza de manera setmanal, i els seus beneficis han estat documentats per Martin Seligman (2019), el pare de la psicologia positiva.

Recursos de relaxació per al dia a dia. Els recursos de relaxació poden adoptar diverses formes, des d'activitats senzilles, com trobar un lloc còmode per seure o submergir-se en la lectura, o bé incloure tècniques més elaborades que requereixen certs nivells d'habilitat. A més, existeixen formes naturals d'aconseguir la relaxació que no impliquen seguir un mètode concret, ja que sorgeixen de la vida quotidiana i estan íntimament relacionades amb els interessos i les motivacions individuals (Rodríguez et al., 2005).

Per tant, és fonamental identificar aquelles activitats que resulten agradables i significatives, amb la finalitat d'integrar-les a la rutina diària i promoure un millor equilibri emocional. Aquestes pràctiques no només contribueixen al benestar personal, sinó que també faciliten el poder apreciar els petits detalls de la vida com factors essencials en la regulació emocional (Rodríguez et al., 2005).

Al mòdul presentat a *Annexos* es recullen diversos recursos de relaxació, proposats per Rodríguez et al. (2005). Aquests evidencien que la relaxació pot integrar-se en la vida diària de manera natural, contribuint a la millora del benestar emocional i al manteniment d'un bon equilibri psicològic.

Limitacions i Punts Forts

Limitacions

- **Característiques de la mostra:** La mostra de 47 persones està molt localitzada geogràficament (al voltant del Maresme i l'Hospital de Mataró) i es va obtenir mitjançant el mètode de "boca-orella", el que podria limitar la generalització dels resultats. Alhora, una mostra més àmplia hauria afavorit més capacitat de generalització dels resultats.
- **Biaix de gènere:** Hi ha una sobrerepresentació femenina (entre el 75% i el 87% segons la fase), tot i que això evidencia la realitat social actual del rol de cuidador.
- **Estat del prototip:** L'objectiu final del TFG és definir i crear un prototip d'una guia. Per tant, encara no s'ha dut a terme una implementació real ni s'ha avaluat l'impacte d'aquest material en la salut mental dels cuidadors a llarg termini.

- **Dificultats en la captació inicial:** Vaig haver d'eliminar 9 enquestats perquè eren de pacients i no de familiars, fet que indica que els canals de difusió podrien haver estat més precisos per arribar exclusivament al grup diana.

Punts forts

- **Fonamentat en dades reals:** El treball es basa en una enquesta realitzada a 47 familiars (després de filtrar la mostra inicial de 56). Això permet que el producte s'ajusti a les necessitats reals que es viuen en l'entorn oncològic.
- **Estructura per fases:** La guia es divideix en tres etapes clau (tractament, finalització i fase avançada), reconeixent que les necessitats dels cuidadors no són fixes i evolucionen amb el temps durant la malaltia.
- **Utilitat percebuda:** Tots els participants de l'enquesta van coincidir que una guia psicoeducativa seria molt útil, el que valida la importància del projecte.
- **Proposta pràctica i aplicada:** El treball inclou el desenvolupament d'un mòdul complet sobre la gestió emocional, amb tècniques concretes basades en evidència, convertint-lo en un recurs que es pot utilitzar directament.
- **Rigor metodològic i ètic:** S'ha fet servir un procés de codificació inductiu per analitzar les respostes obertes, comptant amb el suport d'experts (una psicooncòloga i una infermera) per a la difusió i el disseny de l'enquesta.
- **Revisió professional:** Tant l'estructura de la guia com el mòdul creat han estat revisats per una psicooncòloga. Les seves aportacions i correccions s'han integrat al treball, millorant la qualitat i coherència clínica dels continguts.

Perspectives de Futur

Atès que aquest projecte ha establert una base sòlida i ha desenvolupat un prototip inicial, considero diverses línies de continuïtat amb l'objectiu de convertir aquest treball en una eina d'intervenció real i útil.

En primer lloc, una de les propostes és continuar el procés de **digitalitzar el projecte** mitjançant la creació d'una plataforma web d'accés obert on es pugui consultar la guia completa. Això permetria que familiars i professionals tinguessin accés lliure al document principal, així com als continguts teòrics, pràctics i al mòdul específic de gestió emocional que s'ha desenvolupat. Aquesta proposta respon a la necessitat de tenir materials psicoeducatius accessibles i de fàcil consulta a escala estatal.

En el següent enllaç trobareu la versió en línia de la guia, a través d'una pàgina web creada i anomenada *Cuidar sense perdre's*: <https://cuidarsenseperdres.vercel.app/>. Cal tenir en compte que, actualment, la web recull únicament el contingut desenvolupat del TFG; l'estructura de la guia, i el mòdul *Gestionar les pròpies emocions i l'estrès*. També es pot consultar la recerca bibliogràfica feta, com les dades de l'enquesta.

En segon lloc, seria molt útil incorporar un **sistema de suggeriments i millora contínua** a través d'un canal de contacte dins la mateixa plataforma. Això permetria que cuidadors i professionals sanitaris compartissin les seves valoracions sobre la utilitat del recurs i fessin suggeriments de millora basats en la seva experiència. A més, tenint en compte que la mostra

inicial pot resultar poc representativa, aquest sistema facilitaria arribar a un nombre més ampli i divers de persones, que també podrien aportar els seus propis suggeriments. D'aquesta manera, la guia podria fonamentar-se progressivament en una mostra cada vegada més extensa i heterogènia, actualitzant-se periòdicament i adaptant-se a les necessitats canviants de l'entorn oncològic.

A més, una línia futura important seria **completar el desenvolupament de tots els blocs temàtics** que es van plantejar inicialment, amb l'objectiu de poder oferir un recurs psicoeducatiu integral. D'aquesta manera, també es podria dur a terme la seva implementació i avaluar l'impacte del material en la salut i el benestar dels cuidadors a llarg termini.

Finalment, també es proposa establir **col·laboracions amb institucions** com l'Associació Maresme Oncològic o l'Hospital de Mataró, que ja han participat en la difusió de l'enquesta, per dur a terme estudis d'implementació que permetin avaluar l'eficàcia real de la guia.

Conclusions

Els resultats obtinguts mostren que s'ha assolit l'objectiu principal del treball: s'han investigat les necessitats i experiències dels familiars de persones amb càncer, i s'ha creat un prototip de guia psicoeducativa adaptada a les diverses fases del procés oncològic. Aquest enfocament ha permès combinar la revisió teòrica amb una aplicació pràctica que respon a la necessitat identificada.

L'anàlisi de les dades recollides d'una mostra de 47 cuidadors revela una realitat important; tot i que l'atenció i el suport a la persona malalta són fonamentals, els familiars sovint es troben sense acompanyament emocional ni informació suficient. Aquests resultats posen de manifest la necessitat de crear recursos específics per als cuidadors, com de millora de la seva visibilitat dins del procés assistencial.

En termes aplicats, el treball presenta un prototip de guia psicoeducativa que inclou continguts enfocats en la regulació emocional, el suport psicològic i l'acompanyament durant el procés oncològic. També s'ha elaborat específicament el mòdul *Gestió de les pròpies emocions i l'estrès*, que inclou un component psicoeducatiu dedicat a entendre i normalitzar les emocions, així com un conjunt de tècniques per ajudar a regular-les. Aquest mòdul és un bon exemple de l'enfocament pràctic del treball i de la seva orientació cap a la promoció del benestar emocional dels cuidadors.

Encara que la guia no es presenta de manera completa, el prototip i mòdul elaborats proporcionen una base ben estructurada que pot ser desenvolupada i ampliada en futures investigacions.

Entre les limitacions del treball, cal destacar les característiques de la mostra i la manca de validació empírica del prototip proposat. En aquest sentit, les futures línies d'investigació podrien centrar-se a avaluar l'eficàcia de la guia i la seva implementació, amb l'objectiu de valorar l'impacte real en el benestar emocional dels cuidadors.

En conjunt, els resultats obtinguts, conjuntament amb el prototip i mòdul creats, remarquen i donen importància a incorporar intervencions psicoeducatives accessibles i preventives per als familiars de persones amb càncer, així com de promoure una atenció integral que tingui en compte tant a la persona afectada com el seu entorn proper.

ANNEXOS

ANNEX 1: Estructura de la Guia i Desenvolupament d'un Mòdul

ESTRUCTURA D'UNA GUIA PER A FAMILIARS DE PERSONES AMB CÀNCER

1. Introducció

- A qui va dirigida la guia?
- Què és la psicooncologia i per a què és necessària?
- El paper del cuidador

2. Comprendre el procés oncològic

2. 1. Fase de tractament

- Què implica el tractament oncològic?
- Els diferents processos del tractament oncològic
- Efectes secundaris, canvis físics i psicològics

2. 2. Fase de finalització del tractament

- Què implica acabar el tractament?
- Canvis en el dia a dia
- Efectes residuals

2. 3. Fase avançada i final de vida

- Què implica la fase avançada?
- Cures pal·liatives
- Deteriorament físic

3. Impacte emocional del cuidador al llarg del procés

3. 1. Afrontar la por i la incertesa

- Viure amb la incertesa
- Tractament: Por al pronòstic
- Finalització del tractament: Por a la recaiguda
- Fase avançada: Por a la mort

3. 2. Patiment del cuidador

- L'ansietat associada a les cures
- Inseguretats emergents
- Orientacions pràctiques

3. 3. Acceptació i adaptació

- Tractament: Adaptació a la malaltia
- Finalització del tractament: Adaptació a la nova realitat
- Fase avançada: Dol anticipat i preparació per a la pèrdua

3. 4. Gestió emocional i estrès del cuidador

- Entendre les nostres emocions
- Estratègies de regulació emocional

4. Acompanyament a la persona afectada

4. 1. Estratègies d'acompanyament emocional segons la fase de la malaltia

4. 2. Comunicació

- Escolta activa, assertivitat i empatia
- Com parlar de temes difícils

5. Suport social i familiar del cuidador

- Com demanar ajuda
- Importància del suport social i l'expressió emocional
- Compartir experiències: Grups de suport

6. Recursos de suport

- Què és el suport psicooncològic i per a què serveix?
- Possibles recursos de suport (psicòlegs, associacions, entitats, grups de suport...)

MÒDUL: GESTIONAR LES PRÒPIES EMOCIONS I L'ESTRÈS

1. ENTENDRE LES NOSTRES EMOCIONS

Cuidar implica impacte emocional

Cuidar a una persona amb càncer pot ser una experiència molt estressant, que pot resultar molt exigent, tant físicament com emocionalment. Sovint, això significa fer canvis en la vida diària: ajustar rutines, reduir les activitats socials, assumir noves responsabilitats i estar constantment atent a les necessitats de l'altra persona. Amb el temps, aquesta dedicació constant pot portar a una sensació de sobrecàrrega. És comú que les persones que cuiden experimentin cansament acumulat, dificultats per desconnectar o la sensació que no tenen espai per a elles mateixes. L'impacte no és només emocional, sinó que també es pot manifestar físicament. Poden aparèixer símptomes com un cansament persistent, problemes de son, mals de cap, canvis en la gana o tensió corporal. Emocionalment, és freqüent sentir estrès continu, irritabilitat, tristesa o desànim, així com una sensació de buit o apatia. Quan aquestes situacions es prolonguen, poden afectar significativament la qualitat de vida. No obstant això, és molt comú que aquest malestar quedi en segon pla, ja que l'atenció es dirigeix principalment cap a la persona malalta. Reconèixer que cuidar també t'afecta a tu no és un signe de debilitat, sinó un pas fonamental per poder cuidar-te a tu mateix.

Quines emocions poden aparèixer?

Durant el procés de la malaltia, és completament normal sentir una gran gamma d'emocions. No hi ha una única manera de viure-ho, i sovint, diferents emocions poden coexistir al mateix temps. Entre les més comunes, podem trobar la por davant la incertesa sobre el futur o l'evolució de la malaltia; la tristesa pels canvis, les pèrdues o el patiment de la persona estimada; la impotència per no poder controlar la situació; l'ansietat o l'angoixa que ve de la preocupació constant; la incertesa sobre què passarà, i la soledat que sents quan creus que els altres no acaben d'entendre el que vius. També poden aparèixer emocions més difícils d'expressar, com la culpa per pensar que no estem fent prou, la vergonya per com ens sentim o reaccionem, o el bloqueig emocional, que pot fer-nos sentir com si no poguéssim sentir o expressar res. Tot i que sovint les emocions negatives són les que predominen, també hi ha espai per a emocions positives com l'esperança,

la confiança, l'amor o el sentiment de connexió amb la persona que cuidem, així com la satisfacció de poder estar al seu costat. Aquestes emocions poden actuar com un suport en moments difícils i ajudar-nos a sostenir la situació. És important recordar que la intensitat emocional pot variar al llarg del procés. Els primers mesos solen ser especialment intensos, ja que impliquen un gran impacte inicial i moltes adaptacions. Amb el temps, el malestar pot canviar, però sovint es manté en forma d'estrès o preocupació constant, especialment si les nostres pròpies necessitats queden desateses.

Aquestes emocions són adaptatives

Encara que a vegades les emocions puguin ser incòmodes o difícils de gestionar, no apareixen per casualitat. Totes elles tenen una funció i ens ajuden a adaptar-nos al que vivim. Per exemple; la por ens manté alerta i ens ajuda a anticipar possibles dificultats, la ràbia pot sorgir quan veiem una situació com a injusta o fora del nostre control i ens proporciona l'energia necessària per reaccionar, la tristesa ens ajuda a processar pèrdues i a adaptar-nos als canvis, mentre que l'ansietat ens prepara per afrontar situacions exigents. Aquestes reaccions són part del funcionament natural del cos i la ment, i han estat útils al llarg del temps per afrontar situacions complexes. En aquest sentit, són adaptatives. Les emocions positives també juguen un paper important, ja que poden ajudar-nos a generar recursos personals i reforçar vincles amb altres persones. Ara bé, quan les emocions es tornen intenses i duren massa temps ens desborden i poden començar a afectar negativament el nostre benestar. Una preocupació constant o una tensió contínua poden fer que el dia a dia sigui més difícil i complicar la situació. Per això, no es tracta d'evitar sentir, sinó d'aprendre a relacionar-nos amb el que sentim d'una manera més saludable.

Per què és important regular les nostres emocions?

Entendre les emocions vol dir aprendre a reconèixer el que sentim, posar-hi nom i trobar maneres de gestionar-ho; no es tracta de fer que les emocions desapareguin, sinó d'evitar que ens desbordin i condicionin completament el nostre dia a dia. Quan regulem les emocions de manera adequada, ens és més fàcil afrontar situacions complicades, sentir-nos més equilibrats, prendre decisions amb més claredat i reduir tant el malestar físic com emocional. Això també ajuda a mantenir relacions més sanes i a sostenir el rol de cuidador d'una manera més saludable al llarg

del temps. D'altra banda, ignorar o reprimir el que sentim pot fer que aquestes emocions s'acumulin. A la llarga, això pot traduir-se en més estrès, tensió física o malestar emocional, i acabar afectant la nostra salut general. Aprendre a regular les emocions és, per tant, una eina fonamental per a la cura personal. No només ens ajuda a sentir-nos millor, sinó que també ens permet cuidar els altres des d'un lloc més sostenible, sense oblidar-nos de nosaltres mateixos.

2. ESTRATÈGIES DE REGULACIÓ EMOCIONAL

LA RESPIRACIÓ PROFUNDA

La respiració és una de les eines més senzilles i efectives per gestionar les emocions. Quan ens trobem en situacions d'estrès o ansietat, la nostra respiració sol ser més superficial i ràpida, mantenint el cos en un estat d'alerta constant. Aprendre a respirar de manera més conscient ens ajuda a activar una sensació de calma i a reduir la tensió tant física com mental. Dins de les tècniques de respiració, es fa especial èmfasi en la combinació de diferents tipus (diafragmàtica, toràcica i clavicular), ja que integrar-les ens permet respirar de manera més completa i equilibrada. L'objectiu d'aquest exercici no és aconseguir la respiració perfecta, sinó entrenar el cos per tornar a un ritme més tranquil.

Tipus de respiració i com practicar-les

1. Respiració diafragmàtica (abdominal)

Aquesta és la clau per a una respiració relaxant. És la manera més natural i eficient de respirar, i és especialment útil per reduir l'ansietat i la tensió.

Com fer-ho pas a pas:

- Seu o estira't en una posició còmoda.
- Col·loca les dues mans a l'abdomen, o una mà al pit i l'altra a l'abdomen.
- Inspira pel nas lentament durant 3 - 5 segons, intentant que només s'elevi l'abdomen (no el pit).
- Expira suaument per la boca durant 3 - 5 segons, deixant que l'abdomen baixi.
- Repeteix el cicle entre 5 i 10 vegades, sense forçar.

El més important és notar com es mou l'abdomen, encara que sigui una mica.

<https://www.youtube.com/watch?v=TuPaMCsnxes>

2. Respiració toràcica

Aquesta tècnica de respiració se centra en la zona del pit i ajuda a augmentar la capacitat pulmonar. És un bon pas intermedi cap a una respiració més profunda i completa.

Aquí tens com fer-ho pas a pas:

- Seu amb l'esquena recta i les espatlles relaxades.
- Si et pot ser útil, col·loca les mans a les costelles per sentir el moviment.
- Inspira pel nas durant 3 - 4 segons, intentant obrir la caixa toràcica cap als costats.
- Expira suaument durant 3 - 4 segons.
- Repeteix-ho durant unes quantes respiracions, mantenint un ritme tranquil.

No cal que forçis l'expansió; el més important és notar com es mou el pit, no inflar-lo al màxim.

<https://www.youtube.com/watch?v=J78TzHsR77k>

3. Respiració clavicular

Aquesta és una respiració més superficial, que sovint es produeix de manera automàtica quan ens sentim angoixats o tensos.

Per practicar-la de manera conscient i poder regular-la, segueix aquests passos:

- Seu amb els braços relaxats.
- Expira tot l'aire que tens als pulmons.
- Inspira suaument, portant l'aire cap a la part alta dels pulmons (sense aixecar les espatlles).
- Nota com les clavícules s'eleva a poc a poc.
- Expira de manera curta i suau.
- Repeteix aquest procés durant 3 - 4 respiracions.

Aquesta respiració no és l'objectiu principal, sinó que forma part del procés per integrar-la amb altres tècniques de respiració més completes.

https://www.youtube.com/watch?v=ed_Ei4qmXD0

4. Respiració completa

Aquesta tècnica combina les tres anteriors i és la més completa per generar una sensació de calma i reduir l'ansietat.

Aquí tens com fer-la pas a pas:

- Seu o estira't en una posició còmoda i relaxa el teu cos.
- Expira tot l'aire dels pulmons.
- Inspira lentament pel nas en tres fases: primer omple l'abdomen, després el pit i finalment la part superior dels pulmons.
- Expira suaument per la boca, deixant que l'aire surti de manera progressiva. Mantingues un ritme lent, continu i sense forçar-lo.
- Repeteix aquest procés mentre mantens una respiració pausada fins que comencis a notar més calma.

<https://www.youtube.com/watch?v=dbYCCb8tgSA>

A l'hora d'utilitzar aquestes tècniques és important saber que aquestes respiracions es poden aplicar en diversos moments del dia, especialment quan comences a sentir tensió, ansietat o sobrecàrrega emocional. També són molt útils abans d'anar a dormir, en moments de preocupació, quan necessites un petit descans o en qualsevol situació que es busqui recuperar l'estat de relaxació. No cal esperar a estar en una situació crítica per fer-les, de fet, com més les practiquis en moments de calma, més fàcil et serà recórrer a elles quan realment les necessitis.

MINDFULNESS

El *mindfulness* és una forma d'entrenar la nostra atenció per poder centrar-nos en el moment present amb més consciència. Sovint, la nostra ment es troba atrapada en preocupacions sobre el passat o el futur, fet que pot incrementar l'estrès i la sensació de sobrecàrrega. Practicar

mindfulness ens ajuda a tornar al present i ser més conscients del que vivim sense jutjar-ho, alhora que ajuda a reduir la reactivitat emocional. Aquestes tècniques no busquen buidar la ment, sinó aprendre a observar el que passa, els pensaments, les emocions i les sensacions, amb distància i acceptació.

Petites pràctiques de mindfulness per al dia a dia

1. *Body scan* (escaneig corporal)

Aquesta pràctica és una excel·lent manera de connectar amb el teu cos i identificar les tensions que s'han acumulat.

Aquí tens com fer-ho pas a pas:

- Seu o estira't en una posició còmoda.
- Tanca els ulls i centra la teva atenció en la respiració durant uns segons.
- Comença a dirigir l'atenció a una part del cos (per exemple, els peus).
- Observa les sensacions sense intentar canviar res (calor, tensió, formigueig, etc.).
- Mantingues l'atenció en aquesta zona durant uns segons i després deixa-la anar.
- Ves pujant progressivament per diferents parts del cos.
- Torna a la respiració abans de finalitzar.
- Obre els ulls i torna a l'entorn lentament.

2. Meditació asseguda

Aquesta és una tècnica que t'ajuda a entrenar la teva atenció en la respiració i a observar els teus pensaments sense quedar-te enganxat a ells.

Aquí tens una guia pas a pas:

- Seu amb l'esquena recta però relaxada.
- Col·loca els peus a terra i deixa les mans reposar a la falda.
- Tanca els ulls o baixa la mirada.
- Dirigeix la teva atenció cap a la respiració del teu cos.
- Pots acompanyar-la mentalment amb les paraules “inspirant” i “expirant”.

- Quan apareguin pensaments, observa'ls i deixa'ls passar sense enganxar-te.
- Torna suaument a la respiració cada vegada que et distreguis.
- Mantingues la pràctica durant uns minuts i, quan acabis, obre els ulls lentament.

3. Meditació dempeus

Aquesta pràctica és ideal per reconnectar amb el teu cos i viure el moment present, sigui en moviment o en pausa.

Com fer-ho pas a pas:

- Posa't a peu dret amb l'esquena ben recta i els peus fermament sostinguts.
- Distribueix el pes del teu cos de manera equilibrada.
- Centra la teva atenció en el fet d'estar dret, sense fer res més.
- Observa la teva respiració de manera natural.
- Nota com els teus peus toquen el terra.
- Dedica uns minuts a mantenir l'atenció plena en aquesta postura.
- Quan acabis, torna a les teves activitats habituals de manera gradual.

4. Caminar conscient

Aquesta pràctica transforma una acció diària en un exercici de consciència plena.

Com fer-ho pas a pas:

- Comença a caminar a un ritme més lent del que estàs acostumat.
- Fixa l'atenció en els teus passos i en com els teus peus toquen el terra.
- Si et va bé, coordina la teva respiració amb el moviment.
- Pots repetir mentalment frases com “aquí i ara” o “estic present”.
- Si la teva ment es distreu, torna suaument a les sensacions de caminar.
- Mantingues la pràctica durant uns minuts.

5. El mig somriure

Aquesta és una tècnica molt senzilla que pot ajudar-te a incidir en el teu estat emocional a través del cos.

Aquí tens com fer-ho pas a pas:

- Comença per relaxar la cara i el cos.
- Eleva lleugerament les commissures dels llavis, sense necessitat de forçar un somriure massa gran.
- Mantingues aquesta expressió durant uns segons mentre respires de manera tranquil·la.
- Observa com canvia la teva sensació interna.
- Pots repetir-ho diverses vegades al dia, especialment en moments d'estrès.

6. Mindfulness en les activitats diàries

El *mindfulness* es pot integrar perfectament en les nostres tasques diàries, on l'objectiu és connectar amb el moment present.

Aquí tens com fer-ho pas a pas:

- Escull una activitat senzilla (com rentar plats, cuinar o ordenar).
- Realitza-la més lentament del que estàs acostumat.
- Centra't en els detalls: les textures, els colors, els moviments.
- Observa el que estàs fent en el moment, sense deixar-te portar pel “pilot automàtic”.
- Si et venen pensaments, torna amb suavitat a l'activitat.
- Intenta evitar distraccions (com el mòbil o la televisió) sempre que puguis.

ESCRITURA EMOCIONAL

L'escriptura emocional és una eina que ens ajuda a organitzar el que sentim. Quan escrivim, no només compartim el que ha passat, sinó que també estructurem els nostres pensaments, donem forma a les nostres emocions i sovint aconseguim veure la situació amb més perspectiva i claredat. Posar en paraules el que sentim pot ser una gran ajuda per entendre millor el que ens passa i disminuir la intensitat emocional, com també descobrir nous significats de les experiències que vivim. Amb el temps, aquest procés ens pot donar més sensació de control i coherència sobre el nostre propi relat i les coses que experimentem. Per tant, no es tracta de fer una bona redacció, sinó d'escriure amb sinceritat.

És important ser conscients de que l'escriptura emocional no té una manera "correcta" de fer-se, cada persona pot adaptar-la al seu propi ritme i necessitats. El més essencial és que sigui un espai segur on puguis expressar-te amb total llibertat i, amb la pràctica, pot esdevenir una eina molt útil per entendre millor les teves emocions i alleugerir la càrrega emocional.

Pràctica de l'escriptura emocional

1. Escriure per expressar el que sents

La clau de l'exercici és deixar fluir el que portes a dins.

Com fer-ho pas a pas:

- Troba un moment tranquil del dia, sense distraccions.
- Agafa un paper o un diari (o el mòbil, si et resulta més còmode).
- Dedica entre 15 i 30 minuts a escriure sobre una experiència que t'hagi causat malestar o una emoció intensa.
- No et preocupis per l'ortografia ni per l'ordre; escriu tal com et surti.
- Intenta incloure què va passar, què vas pensar i com et vas sentir.
- Si sorgeixen emocions fortes, deixa-les fluir sense reprimir-les.

Si no saps per on començar, pots escriure "ara mateix em sento..." i continuar a partir d'aquí.

2. Diari emocional

Un diari és una excel·lent manera de fer un seguiment del teu estat emocional al llarg del temps.

Aquí tens com fer-ho pas a pas:

- Escriu de manera regular (pot ser cada dia o alguns dies a la setmana).
- Anota com et sents i què ha passat durant el dia.
- Inclou també com has reaccionat davant de diferents situacions.
- No cal que escriguis molt: pot ser breu, però ha de ser sincer.
- De tant en tant revisa el que has escrit per veure canvis o patrons.

3. Diari de gratitud

Aquesta pràctica és una manera excel·lent de centrar-te en les coses positives que et passen cada dia, fins i tot les més petites.

Com fer-ho pas a pas:

- Escribeu un cop per setmana (o en dies que tu triïs).
- Fes una llista de 2 a 5 coses per les quals et sents agraït.

Poden ser detalls molt senzills: un gest amable, una conversa agradable, o un moment de tranquil·litat...

- Si et ve de gust, explica breument per què ho valores.
- Intenta mantenir-te constant, fins i tot si les coses que anotes són petites.

4. Carta d'agraïment

Aquesta activitat és una bona manera d'expressar gratitud cap a algú que és important per a tu.

Aquí tens com fer-ho pas a pas:

- Pensa en una persona que hagi deixat una empremta positiva a la teva vida.
- Escribeu-li una carta on expliquis què valores d'ella.
- Intenta ser específic/a: què va fer i com t'ha ajudat.

Pots escriure-la només per a tu mateix o, si et sents còmode, compartir-la amb aquesta persona. El més important és mostrar el teu reconeixement, no buscar la perfecció en la forma de fer-se.

RECURSOS DE RELAXACIÓ EN EL NOSTRE DIA A DIA

La relaxació no sempre necessita tècniques complicades ni haver d'invertir-hi llargues estones, de fet, sovint es pot trobar en petites accions diàries que ajuden a alleugerir la tensió, reconnectar amb el cos, millorar l'estat d'ànim i afavorir la sensació de benestar. La clau és descobrir quines activitats et fan sentir bé i intentar integrar-les de manera natural a la teva rutina. No es tracta d'afegir més càrregues, sinó de reconèixer els moments que ja tens i aprofitar-los per cuidar-te.

1. Estimulació corporal i hàbits saludables

El cos juga un paper fonamental en la regulació emocional, i petites accions físiques poden ser de gran ajuda per alleugerir la tensió acumulada.

- Camina descalç durant uns minuts al dia, quan puguis, per sentir el contacte amb el terra i relaxar els teus peus.
- Intenta mantenir una alimentació regular i equilibrada, sense posar-te massa pressió.
- Pren el sol de manera moderada uns minuts al dia, sempre amb precaució.
- Fes estiraments suaus, especialment en aquelles zones on se t'acumula més tensió.

2. L'entorn i els espais on estem

L'espai físic i la seva decoració tenen un paper molt important en com ens sentim emocionalment. Triar els colors adequats per als llocs on passem tant de temps pot influir significativament en el nostre benestar mental.

- Els colors càlids, com el vermell, el taronja i el groc, poden activar-nos, augmentant la temperatura corporal i la pressió sanguínia, així que és millor fer-ne un ús moderat.
- Els colors freds o suaus, com el verd, el blau, i els tons grisos o violeta clar, ens proporcionen una sensació de relaxament i frescor.
- Els colors clars ens transmeten lleugeresa i llibertat, mentre que els colors més foscos poden fer-nos sentir una mica més oprimits o amenaçats.

És essencial adaptar els colors a la funció de cada espai, especialment en aquells on passem més temps.

3. Relacions socials i suport emocional

Estar en contacte amb altres persones és fonamental per gestionar les emocions. Tenir relacions positives amb familiars, amics o companys ens permet compartir experiències i expressar les nostres inquietuds, fomentant el suport mutu, fet que ajuda a alleugerir tensions i a millorar el nostre benestar emocional.

4. Contacte amb animals

La relació amb els animals de companyia pot tenir un impacte molt positiu en el nostre estat d'ànim. Estar en contacte amb ells ajuda a disminuir la sensació de soledat i s'ha relacionat amb una baixada de la pressió arterial i del ritme cardíac. En alguns casos, pot ajudar a alleugerir els símptomes d'ansietat.

5. Exercici físic

L'exercici físic és una bona manera de relaxar-se i millorar la salut mental.

Entre els molts beneficis que aporta, podem destacar:

- Un augment del benestar i de l'estat d'ànim, gràcies a la producció d'endorfines.
- La reducció de la tensió muscular.
- Un son més reparador.
- Un increment de l'autoestima, la concentració i l'energia.
- Millors habilitats d'adaptació.

6. Contacte físic i afectiu

El contacte físic i afectiu és essencial per a la nostra relaxació, començant des del moment en què naixem. Estar a prop de les persones que estimem ens proporciona una sensació de calma, seguretat i benestar. Tant en la vida personal com en l'àmbit professional, gestos senzills com agafar la mà, tocar l'espatlla, fer una abraçada, o simplement compartir l'espai poden ser molt reconfortants. A més, aquest tipus de contacte no és només físic; també és emocional, ja que ens ajuda a establir connexions que ens permeten oferir suport, afecte i confiança.

ANNEX 2: Resultats de les Dades de l'Enquesta

1. FASE DE TRACTAMENT

Les Característiques Sociodemogràfiques

La mostra inclou vuit participants amb edats que van dels 34 als 72 anys, amb una edat mitjana de 56 anys. Pel que fa al gènere, el 75% de la mostra són dones i el 25% són homes. En relació amb el vincle amb la persona diagnosticada, la distribució dels participants mostra que el 37,5% correspon a parelles, el 25% a germans o germanes, i el 12,5% en cada cas a fills o filles, progenitors i persones amigues. Tots els participants (100%) es troben en la fase de tractament del procés oncològic.

Orientació Emocional en el Moment del Diagnòstic

En el moment inicial del diagnòstic els participants manifesten que un 62,5% dels participants no van rebre cap mena d'orientació emocional quan van conèixer el diagnòstic, i un 37,5% sí que van rebre suport, però a través d'amistats, familiars o associacions. Cap dels participants va obtenir orientació emocional per part de professionals sanitaris. Entre aquells que van rebre suport extern, les fonts de suport es distribueixen de manera equitativa: un 33,3% va rebre ajuda d'amistats i del seu entorn social, un 33,3% de la família, i un 33,3% d'entitats o associacions.

Valoració del Suport Emocional Rebut

En una escala de l'1 al 5, que va des d'un suport emocional rebut insuficient fins a un suport excel·lent, la distribució mostra que el 50% dels participants han puntuat amb un 4, mentre que un 37,5% ho han fet amb un 2 i el 12,5% restant amb un 1.

Aspectes més Difícils d'Afrontar

Els aspectes més destacats pels participants són la incertesa i la por davant l'evolució de la malaltia (50%), seguits dels efectes del tractament i el deteriorament físic (25%). Amb menor proporció, es mencionen les dificultats per acompanyar la persona malalta (12,5%) i l'acceptació de la malaltia i del final de vida (12,5%).

Necessitat i Accessibilitat d'Ajuda Professional

El 75% dels participants manifesten haver sentit la necessitat de rebre ajuda professional (psicòleg/a o grups de suport), mentre que el 25% no ho ha considerat necessari. Pel que fa a l'accessibilitat als recursos, el 50% considera que han estat fàcilment accessibles, mentre que l'altre 50% percep dificultats d'accés.

Estratègies que han Resultat més Útils

Les més mencionades pels participants són el suport professional (42,9%), seguit de l'expressió emocional (28,6%). Amb menor proporció, es troben el suport social i familiar i l'ús d'estratègies personals, ambdues amb un 14,3%.

Utilitat d'una Guia Psicoeducativa

El 100% dels participants creuen que una guia psicoeducativa per a familiars seria molt útil.

Informació que hauria estat Útil des de l'Inici

Els continguts més mencionats pels participants són la informació sobre la malaltia i el seu procés (62,5%), seguit de com acompanyar i donar suport a la persona malalta (25%). En menor proporció, es troba l'orientació sobre recursos disponibles (12,5%).

Temes Prioritaris per Incloure en la Guia

Els temes més seleccionats pels participants són *Com comunicar-se amb la persona afectada*, *Com donar suport a la persona afectada* i *Com afrontar la por, la tristesa o la incertesa*, tots ells amb un 87,5%. A continuació, es troba *Com gestionar les emocions i l'estrès*, amb un 75%.

2. FASE DE FINALITZACIÓ DEL TRACTAMENT

Característiques Sociodemogràfiques

La mostra inclou 23 participants amb edats que van dels 16 als 90 anys, amb una edat mitjana d'uns 50 anys. Pel que fa al gènere, el 87% són dones i el 13% homes, cosa que torna a evidenciar més presència femenina en el rol d'acompanyament. En relació amb el vincle amb la persona diagnosticada, la distribució dels participants indica que el 23,1% correspon a

progenitors/es i un altre 23,1% a fills/es, seguit d'un 19,2% de germans/es, un 15,4% de familiars propers i un 15,4% de persones amigues, mentre que el 3,8% restant correspon a parelles. Tots els participants (100%) es troben en fase de seguiment mèdic després d'haver superat la malaltia.

Orientació Emocional en el Moment del Diagnòstic

En el moment inicial del diagnòstic, manifesten que un 60,9% dels participants no van rebre cap mena d'orientació emocional quan van conèixer el diagnòstic, un 30,4% van rebre suport per part dels professionals sanitaris, i un 8,7% van rebre suport a través d'amistats, familiars o associacions. Entre aquells que van rebre suport extern, un 33,3% va rebre ajuda d'entitats o associacions, un 33,3% del suport familiar, un 16,7% d'amistats i del seu entorn social, i un 16,7% de suport professional psicològic.

Valoració del Suport Emocional Rebut

En una escala de l'1 al 5, la distribució de les valoracions mostra que el 30,4% dels participants han puntuat amb un 1, seguit d'un 26,1% amb un 5, un 21,7% amb un 4, un 17,4% amb un 3 i, finalment, un 4,3% amb un 2.

Aspectes més Difícils d'Afrontar

Els aspectes més destacats són la incertesa i la por davant l'evolució de la malaltia (24%), seguits dels efectes del tractament i el deteriorament físic (20%). Amb menor proporció, s'esmenta el patiment del cuidador i la sensació d'impotència, les dificultats per acompanyar la persona malalta, les dificultats en la comunicació emocional i l'impacte emocional del diagnòstic (totes amb un 12%). Finalment, també apareixen l'acceptació de la malaltia i del final de vida i la manca d'informació i orientació (amb un 4%).

Necessitat i accessibilitat d'ajuda professional

El 47,8% dels participants manifesta no haver sentit la necessitat de rebre ajuda professional (psicòleg/a o grups de suport), mentre que el 52,2% ho ha considerat necessari. Pel que fa a l'accessibilitat als recursos, el 56,5% considera que han estat fàcilment accessibles, mentre que l'altre 43,5% percep dificultats d'accés.

Estratègies que han resultat més útils

Les estratègies més mencionades pels participants són el suport professional (26,3%), seguit de la cerca d'informació i autoajuda i el suport social i familiar, ambdues amb un 21,1%. A continuació, es troba l'ús d'estratègies personals (15,8%), la participació en associacions i grups de suport (10,5%) i, finalment, l'expressió emocional (5,3%).

Utilitat d'una guia psicoeducativa

El 100% dels participants creu que una guia psicoeducativa per a familiars seria útil.

Informació que hauria estat útil des de l'inici

Els continguts més mencionats pels participants són la informació sobre la malaltia i el seu procés (35%), seguits del suport psicològic professional i l'orientació emocional, ambdós amb un 20%. En menor proporció, es troben com acompanyar i donar suport a la persona malalta (15%) i la comunicació amb el professional sanitari (10%).

Temes prioritaris per incloure en una guia

Els temes més seleccionats pels participants són *Com comunicar-se amb la persona afectada* (73,9%) i *Com afrontar la por, la tristesa o la incertesa* (73,9%). Seguidament de *Com donar suport a la persona afectada* (65,2%) i *Com gestionar les emocions i l'estrès* (65,2%). Amb menor freqüència, s'esmenten *l'Autocura i el benestar del cuidador* (52,2%) i els *Recursos de suport psicològic i/o social* (43,5%).

3. FASE DE MALALTIA AVANÇADA

Característiques sociodemogràfiques

La mostra inclou 15 participants, amb edats que van dels 23 als 64 anys, amb una edat mitjana de 52 anys. Pel que fa al gènere, un 86,7% són dones i un 13,3% són homes. En relació amb el vincle amb la persona diagnosticada, la distribució mostra que el 38,9% correspon a fills/es, seguit d'un 16,7% tant de progenitors/es com de familiars propers, un 11,1% de germans/es i persones amigues, mentre que el 5,6% restant correspon a parelles. Tots els participants (100%) es troben en fase de malaltia avançada i de final de vida.

Orientació emocional en el moment del diagnòstic

En el moment inicial del diagnòstic, manifesten que un 66,7% dels participants no van rebre orientació emocional quan van conèixer el diagnòstic, un 26,7% van rebre suport per part dels professionals sanitaris, i un 6,7% van rebre suport a través d'amistats, familiars o associacions. Entre aquells que van rebre suport extern, un 50% va rebre ajuda d'amistats i entorn social, un 30% del suport familiar, i un 10% de suport professional psicològic i d'entitats i associacions respectivament.

Valoració del suport emocional rebut

En una escala de l'1 al 5, la distribució de les valoracions mostra que el 53,3% dels participants han puntuat amb un 1, mentre que un 20% ho han fet amb un 3 i un altre 20% amb un 4, i el 6,7% restant ha assignat una puntuació de 5.

Aspectes més difícils d'afrontar

Els aspectes més mencionats pels participants són l'acceptació de la malaltia i del final de vida (35,3%), seguits del patiment del cuidador i la sensació d'impotència, les dificultats per acompanyar la persona malalta, els efectes del tractament i el deteriorament físic, l'impacte emocional del diagnòstic i la manca d'informació i orientació, tots ells amb un 11,8%. Finalment, les dificultats en la comunicació emocional representen el 5,9% de les respostes.

Necessitat i accessibilitat d'ajuda professional

El 66,7% dels participants manifesten haver sentit la necessitat de rebre ajuda professional, mentre que el 33,3% no ho ha considerat necessari. Pel que fa a l'accessibilitat als recursos, el 66,7% considera que no han estat fàcilment accessibles, mentre que per l'altre 33,3% sí que ho ha sigut.

Estratègies que han ajudat més

Les estratègies mencionades pels participants inclouen principalment el suport social i familiar (30,8%) i el suport professional (23,1%). En menor proporció, es recull la cerca d'informació i

autoajuda (15,4%), així com l'ús d'estratègies personals, la participació en associacions i grups de suport i l'expressió emocional (7,7%).

La utilitat d'una guia psicoeducativa

El 100% dels participants creu que una guia psicoeducativa per a familiars seria útil.

Informació que hauria estat útil des del principi

Els continguts més mencionats pels participants són l'orientació emocional i psicoeducació, el suport psicològic professional i la informació sobre la malaltia i el seu procés, tots tres amb un 25%. A continuació, es troba la comunicació amb el professional sanitari (12,5%), mentre que la manera d'acompanyar i donar suport a la persona malalta i l'orientació sobre recursos disponibles representen un 6,3% cadascun.

Temes prioritaris per incloure en una guia

Els temes més seleccionats pels participants són *Com afrontar la por, la tristesa o la incertesa* (100%), seguit de *Com comunicar-se amb la persona afectada* (80%). A continuació, es troben *Com donar suport a la persona afectada* (66,7%), *Com gestionar les emocions i l'estrès* (60%) i els *Recursos de suport psicològic i/o social* (53,3%).

Per a consultar les dades completes, es pot accedir al document Excel mitjançant el següent enllaç:

Respostes completes prèvies a la categorització:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qs__J1fUa5Aoi7U3GtrFCv_mJnPfRXX8N79iLYPtmk/edit?usp=sharing

Respostes de les enquestes mitjançant procés inductiu:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hMYxtSDluBE5ECXsTLABGL5yngS40VNTlrlWb1CYeDE/edit?usp=sharing>

REFERÈNCIES

American Cancer Society. (2025). *Support programs and services for caregivers*.
<https://www.cancer.org/support-programs-and-services.html#Caregivers>

Asociación Española Contra el Cáncer. (2025). *Te ayudamos*.
<https://www.contraelcancer.es/es/te-ayudamos>

Bernal Ruíz, J. A. (2020). La relajación y la respiración en la Educación Física y el deporte. Colección de Educación Física y Deporte. Universidad de Nebrija. Editorial Actualidad Nebrija

Chiquelho, R., Neves, S., Mendes, A., Relvas, A. P., & Sousa, L. (2011). *proFamilies: A psycho-educational multi-family group intervention for cancer patients and their families*. *European Journal of Cancer Care*, 20(3), 337-344.

Coyne, E., Heynsbergh, N., & Dieperink, K. B. (2020). Acknowledging cancer as a family disease: a systematic review of family care in the cancer setting. *European Journal of Oncology Nursing*, 49, 101841.

Cuijpers, P., Pineda, B. S., Quero, S., Karyotaki, E., Struijs, S. Y., Figueroa, C. A., ... & Muñoz, R. F. (2021). Psychological interventions to prevent the onset of depressive disorders: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Clinical Psychology Review*, 83, 101955.

Donker, T., et al. (2009). Psychoeducation for depression, anxiety and psychological distress: A meta-analysis. *BMC medicine*, 7(1), 79.

Filipponi, C., Masiero, M., Chichua, M., Traversoni, S., & Pravettoni, G. (2025). Navigating the emotional landscape: exploring caregivers' journey alongside breast cancer survivors with chronic pain. *Supportive Care in Cancer*, 33(1), 32.

García-Grau, E., Fusté Escolano, A., & Bados López, A. (2008). Manual de entrenamiento en respiración. *Universitat de Barcelona*.

Germer, C.K. (2005) Mindfulness. What is it? What does it matter? En C.K. Germer, R.D. Siegel y P.R. Fulton (eds.): *Mindfulness and Psychotherapy*. Nueva York: Guilford Press, págs., 3-27.

Given, B. A., Given, C. W., & Sherwood, P. (2012). The challenge of quality cancer care for family caregivers. In *Seminars in oncology nursing* (Vol. 28, No. 4, pp. 205-212). WB Saunders.

Glajchen, M. (2004). The emerging role and needs of family caregivers in cancer care. *The journal of supportive oncology*, 2(2), 145-155.

Hodges, L. J., Humphris, G. M., & MacFarlane, G. (2005). A meta-analytic investigation of the relationship between the psychological distress of cancer patients and their carers. *Social science & medicine*, 60(1), 1-12.

Irrázaval, M., Prieto, F., & Armijo, J. (2016). Prevención e intervenciones tempranas en salud mental: una perspectiva internacional. *Acta bioethica*, 22(1), 37-50.

Janocha, A., Shpakou, A., Sobieszczańska, M., Kałka, D., Klimatckaia, L., Woźniak, W., ... & Małyszczak, K. (2018). Emotions and their cognitive and adaptive functions. *Progress in Health Sciences*, 8, 178-184.

Kessen, C. (2009). Living fully: Mindfulness practices for everyday life. *Mindfulness and social work*, 31-44.

Kim, Y., & Given, B. A. (2008). Quality of life of family caregivers of cancer survivors: across the trajectory of the illness. *Cancer*, 112(S11), 2556-2568.

López-Hernández, L. (2016). Técnicas mindfulness en centros educativos. Desarrollo académico y personal de sus participantes. *Revista española de orientación y psicopedagogía*, 27(1), 134-146.

Lyubomirsky, S. (2021). La ciencia de la felicidad. Urano.

Mayne, T. J. (2001). Emotions and health. In T. J. Mayne & G. A. Bonanno (Eds.), *Emotions: Current issues and future directions* (pp. 361–397). The Guilford Press.

McCann, T. V., & Lubman, D. I. (2014). Qualitative process evaluation of a problem-solving guided self-help manual for family carers of young people with first-episode psychosis. *BMC psychiatry*, 14(1), 168.

McCorkle, R., & Given, B. (2012). The emotional Responses of family caregivers: Living with cancer and helping families cope. In *Cancer Caregiving in the United States: Research, Practice, Policy* (pp. 39-62). New York, NY: Springer New York.

Monsivais, C. L. R. (2023). La escritura como terapia de liberación emocional para reducir síntomas de la depresión. Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores.

Morales, T. A. (2018). Hologramas interactivos para la bio-retroalimentación de la respiración de niños con autismo. *La referencia*, 6 (4), 2-5.

Northouse, L. L., Katapodi, M. C., Schafenacker, A. M., & Weiss, D. (2012). The impact of caregiving on the psychological well-being of family caregivers and cancer patients. In *Seminars in oncology nursing* (Vol. 28, No. 4, pp. 236-245). WB Saunders.

Northouse, L., Williams, A. L., Given, B., & McCorkle, R. (2012). Psychosocial care for family caregivers of patients with cancer. *Journal of clinical oncology*, 30(11), 1227-1234.

Ortega-Pérez, M., Rodríguez-Rodríguez, L. E., & Mercadet-Portillo, O. E. (2023). El aprendizaje de las técnicas de respiración en la enseñanza-aprendizaje de la Educación Física. *Educación y sociedad*, 21(Especial), 135-154.

Overchuk, V., Liashch, O., Smulson, M., Korniienko, I., & Lapshova, N. (2024). Dynamics of emotional states in oncology patients depending on the stage of the disease.

Pandey, R., & Choubey, A. K. (2010). Emotion and health: An overview. *SIS Journal of Projective Psychology & Mental Health*, 17(2).

Pareja, M. Á. V. (2006). Mindfulness. *Papeles del psicólogo*, 27(2), 92-99.

Pérez, O. G., & Bello, N. C. (2017). Regulación emocional: definición, red nomológica y medición. *Revista mexicana de investigación en psicología*, 8(1), 96-117.

Ponciano-Rodríguez, G., & Morales-Ruiz, A. (2007). La escritura emocional como una herramienta para el tratamiento psicológico del tabaquismo. *Salud pública de México*, 49(suppl 2), s280-s289.

Puerto Pedraza, H. M. (2015). Calidad de vida en cuidadores familiares de personas en tratamiento contra el cáncer. *Revista cuidarte*, 6(2), 1029-1040.

Riso, W. (2022). *Atrévete a ser quien eres (aunque no gustes)*. Planeta.

Rodríguez, T. R., Rodríguez, C. M. G., & Pérez, R. C. (2005). Técnicas de relajación y autocontrol emocional. *MediSur*, 3(3), 55-70.

Seligman, M. (2019). *El círculo de la esperanza*. Penguin Random House.

Siegel, D. (2012) *Mindfulness y psicoterapia*. Barcelona: Paidós.

Stenberg, U., Ruland, C. M., & Miaskowski, C. (2010). Review of the literature on the effects of caring for a patient with cancer. *Psycho-oncology*, 19(10), 1013-1025.

Vissupe, M. D. C., Morales, V. G., Gallo, L. A., Valdivia, Y. Á., & Rodríguez, D. S. (2016). Apoyo emocional a cuidadores principales de niños con enfermedades oncológicas, a partir de una guía psicoeducativa (GP). *Revista de Psicología*, 18(1), 26-34.

Weare, K. (2012). Evidence for the impact of mindfulness on children and young people.

Williams, M. y Penman, D. (2010) Mindfulness: an eight week plan for finding peace in a frantic world. Barcelona: Kairós.

Yang, W. F. Z., Lee, R. Z. Y., Kuparasundram, S., Tan, T., Chan, Y. H., Griva, K., & Mahendran, R. (2021). Cancer caregivers unmet needs and emotional states across cancer treatment phases. *PLoS One*, 16(8), e0255901.

Zhou, Y., Zhao, D., Zhu, X., Liu, L., Meng, M., Shao, X., ... & Zhu, G. (2023). Psychological interventions for the prevention of depression relapse: systematic review and network meta-analysis. *Translational Psychiatry*, 13(1), 300.